Introduction à l'économie de la santé

Les Grandes lignes

Qu'est-ce que l'économie

Qu'est-ce que la santé et les soins de santé?

Qu'est-ce que l'économie de la santé?

Pourquoi est-il important?

Ce qui rend le marché des soins de santé différent du marché ou d'autres biens?

Quel type de questions demandez-vous à un économiste de la santé?

Qu’est-ce que l’économie ?

A quoi ça sert ?

Le terme « économie » (*oikonomia)* signifie, depuis que les Grecs l'ont introduit, administration de la maison

L' économique est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution, aux échanges et à la consommation des richesses (biens et services).

En français « économie » est synonyme de « parcimonie »

Par extension, est économique tout ce qui permet d'atteindre l'objectif fixé avec un minimum de moyens.

But de l'économie

Besoins
illimités

→ Economie ←

Ressources
rares

↓

Satisfaire le plus de besoins possibles
en rationalisant l'utilisation des ressources



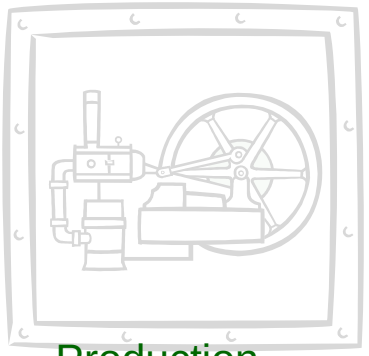
Travail



Rôle de l'Etat

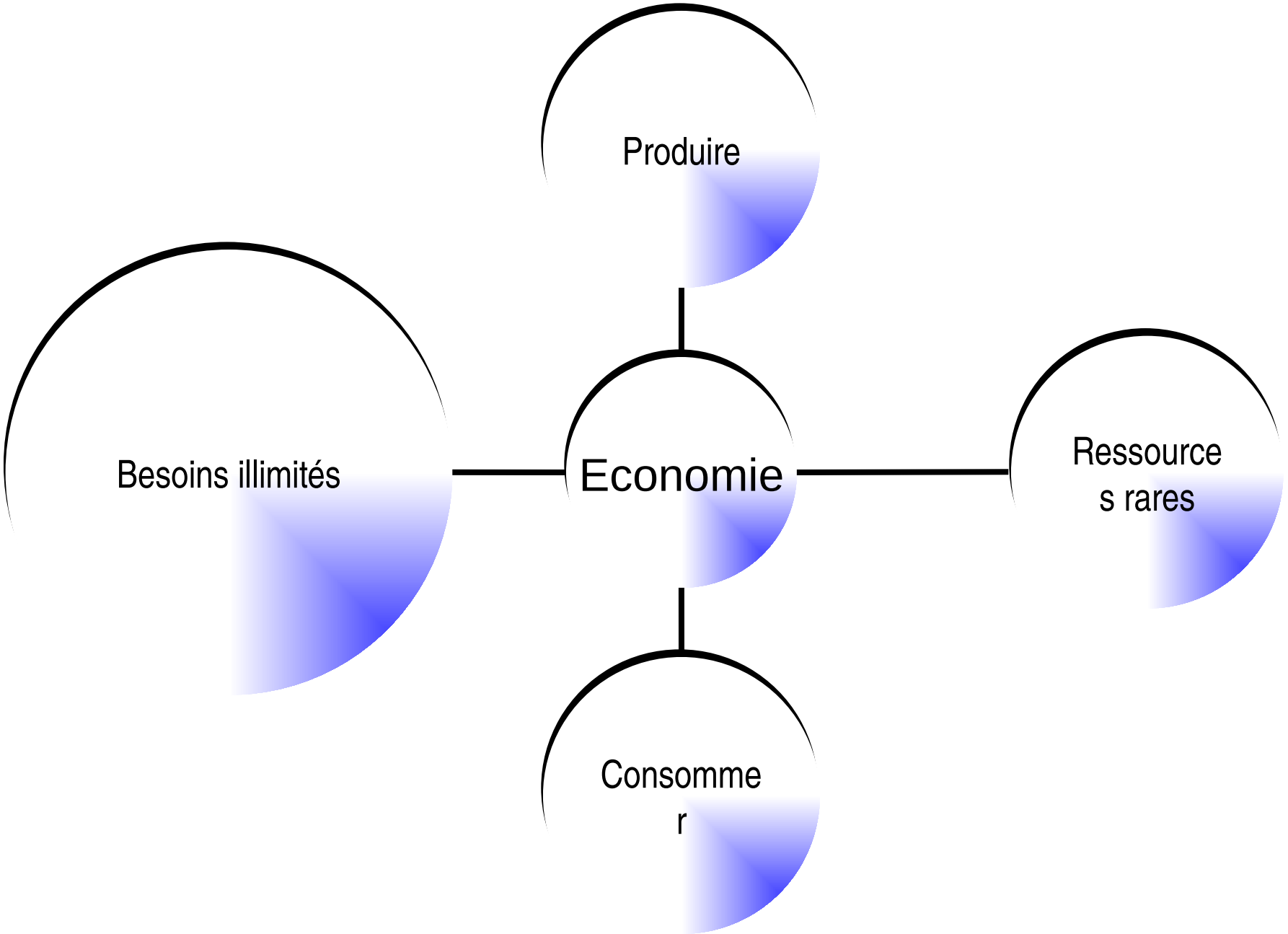


Monnaie

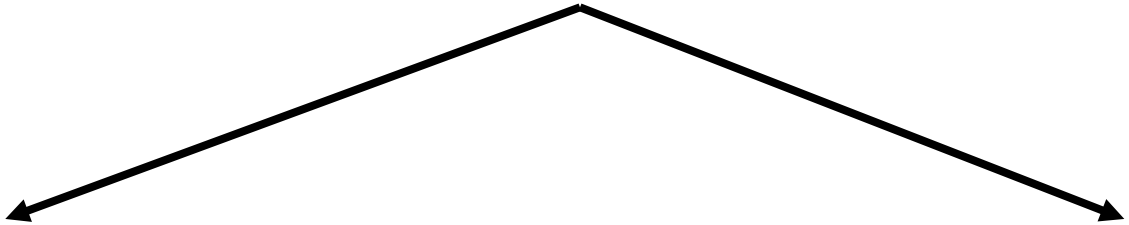


Production

L'économie, une science de *gestion des ressources*



Les besoins



Non économiques

(ne s'achètent pas !)

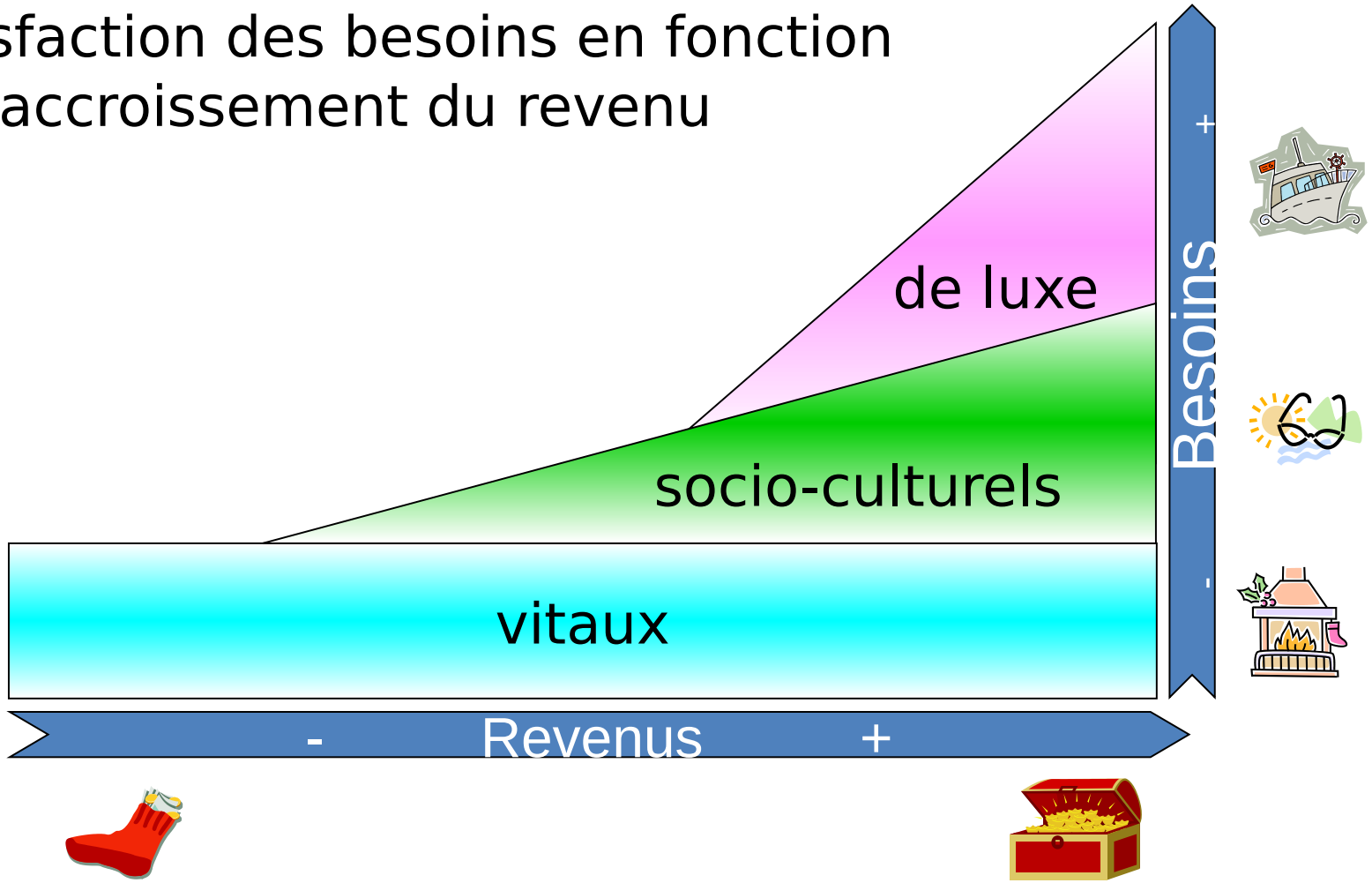
Économiques

(réclament une activité de production)

- somatiques (respirer, dormir)
- moraux
- spirituels
- affectifs
- sociaux (parler, discuté, partager)

Les besoins économiques

Satisfaction des besoins en fonction de l'accroissement du revenu



Secteurs d'activité

Primaire	Secondaire	Tertiaire
Exploitation du sol et des matières premières. • agriculture • sylviculture • élevage • extraction minière • etc.	Industrie de transformation des matières premières • électricité • construction • transformation • menuiserie • etc.	Entreprises de services • administration • **santé** • banques • assurances • transports • loisirs • etc.

la santé ?

La santé est un concept à multiples facettes et n'est pas facilement mesurable.

Définition de l'OMS:

La santé est un état de bien-être complet physique et mental et non pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité (OMS, 1948)

Reportez-vous à l'état de santé des peuples (leur état de santé).

la santé ?

- ✓ Une partie importante du capital humain

  -- Le capital humain: valeur de l'apprentissage, l'expérience et la capacité incarnée chez les travailleurs qui augmente la productivité et les revenus.
  --A tout: s'accumule et se déprécie

- ✓ Individuel ou des ménages peuvent améliorer leur santé grâce à l'utilisation des soins de santé, l'alimentation.

  --Production de la santé
  Fonctions de production de santé
  Déterminants de la santé

Qu'est-ce que les soins de la santé?

- Définition: La prévention, le traitement et la gestion de la maladie et la préservation de la santé mentale et bien-être physique à travers les services offerts par la médecine et autres professions paramédicales.

soins versus santé?

--Différence importante entre la santé et les soins de santé

Les soins de santé peuvent être échangés sur le marché, mais la santé ne peut pas.

--Exiger des soins de santé pour améliorer notre santé

La demande de soins de santé

--Marchés des soins de santé varient d'un marché pour d'autres produits

Rôle pour le gouvernement

- FACE A UN PROBLEME DE SANTE

  - logique médicale

  - logique épidémiologique

  - logique économique

ECONOMIE DE LA SANTE

- Discipline récente:
  * Importance accrue suite aux crises économiques et aux déficits des systèmes de sécurité sociale
  * Propose des solutions aux problèmes économiques financiers de l'heure.
- Définition:

* Besoins sanitaires illimités et ressources limitées

* Manière de répartir les ressources rares entre des buts compétitifs

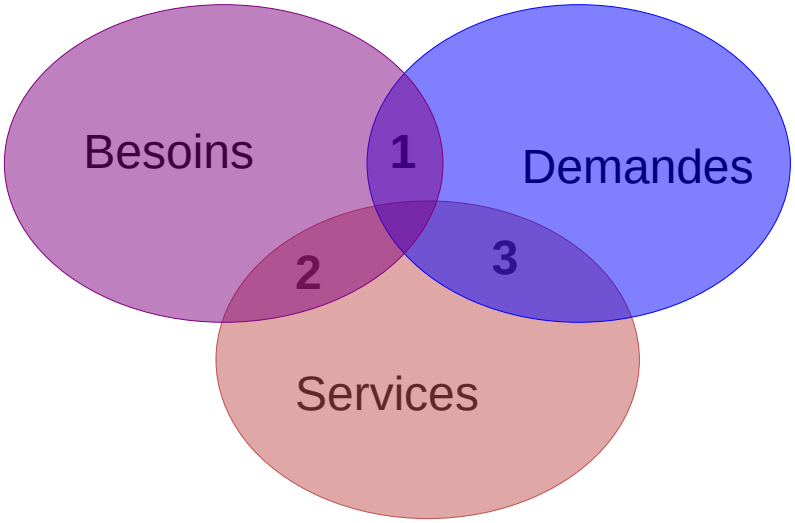
Pourquoi est-il important?

1. La taille de l'économie de la santé est importante et croissante

2. Rôle du gouvernement dans les marchés de la santé

3. Marché des soins de santé est différent

Convergence des besoins, des demandes et des services de santé



- Besoins existants, demandes exprimées, pas de service disponible 1

→ Mécontentement

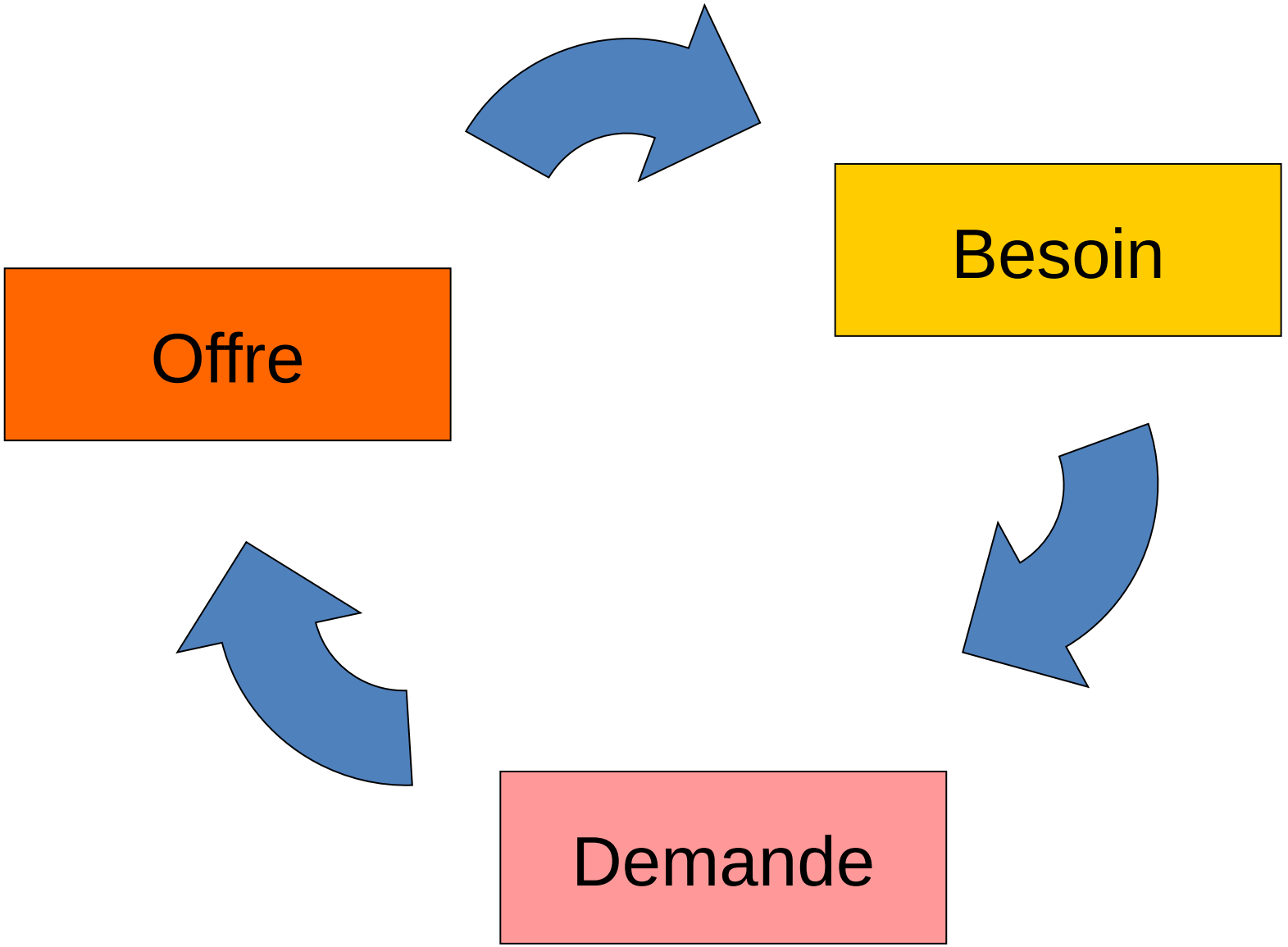
- Besoins existants, services disponibles, pas de demande exprimée 2

→ Sous utilisation

- Demande exprimée, services existants, pas de besoin réel

→ Gaspillage

L’enchaînement besoin-demande-offre



Consommation Soins Biens Médicaux

- Soins hospitaliers.....45%
  - Soins Hospitaliers public (78%)
  - Soins hospitaliers privés (19%)
  - Sections médicalisées publiques et privées (3%)
- Soins ambulatoires..... 25%
  - Médecins (47%)
  - Auxiliaires médicaux (20%)
  - Dentistes (20%)
  - Analyses (9%)
  - Cures thermales (3%)
- Médicaments.....22%
- Prothèses.....6%
- Transports.....2%

L'importance de l'évaluation économique.

Intérêt de l'économie de la santé?

1. Économie de la santé est l'étude de la façon dont (rares) ressources sont allouées et à l'intérieur de l'économie de la santé.
   --La production de soins de santé (médecins, spécialistes, ou infirmières).
   --Comment peut-on distribuer des soins de santé dans la population?
   -Sur la base qui peuvent payer ou qui en ont besoin ou une combinaison.
   --Combien d'argent le gouvernement devrait consacrer aux soins de santé?

Qu'est-ce que l'économie de la santé?

2/Démontre l'ampleur et l'importance du secteur de la santé par exemple

- En combien de temps il pourrait être de plus en plus et pourquoi

3/Ce qui le rend différent des autres marchés et comment notre analyse peut être nécessaire d'ajuster

4/Modèles, les déterminants de l'état de santé, comment la politique gouvernementale peut améliorer l'état de santé à court et à long terme

SANTE :Structure des Dépenses

Dépense Nationale deSanté(DNS)

Dépense Courante de Santé (DCS)

Consommation Médicale Totale (CMT)

1) <u>Consom de soins et de biens médicaux CSBM 98%</u>
   - Soins hospitaliers
   - Soins ambulatoires
   - Soins aux collectivités (armée, prison)
   - Lutte maladie mentale
   - Commerce biens médicaux
2) <u>Consom services de médecine préventive CSMP 2%</u>
   - Médecine scolaire, travail, PMI, CPF, CASPA,

Indemnités journalières, Recherche médicale et pharmaceutique, prévention collective, contrôle sanitaire, enseignement, subventions, gestion générale de la santé

Dotation en capital, Aide à l'investissement

Les économistes voir du monde …

Pessimiste: ½ bouteille vide

Optimiste: ½ bouteille pleine

Économiste: ½ bouteille PERDU!

La «santé économique» problème

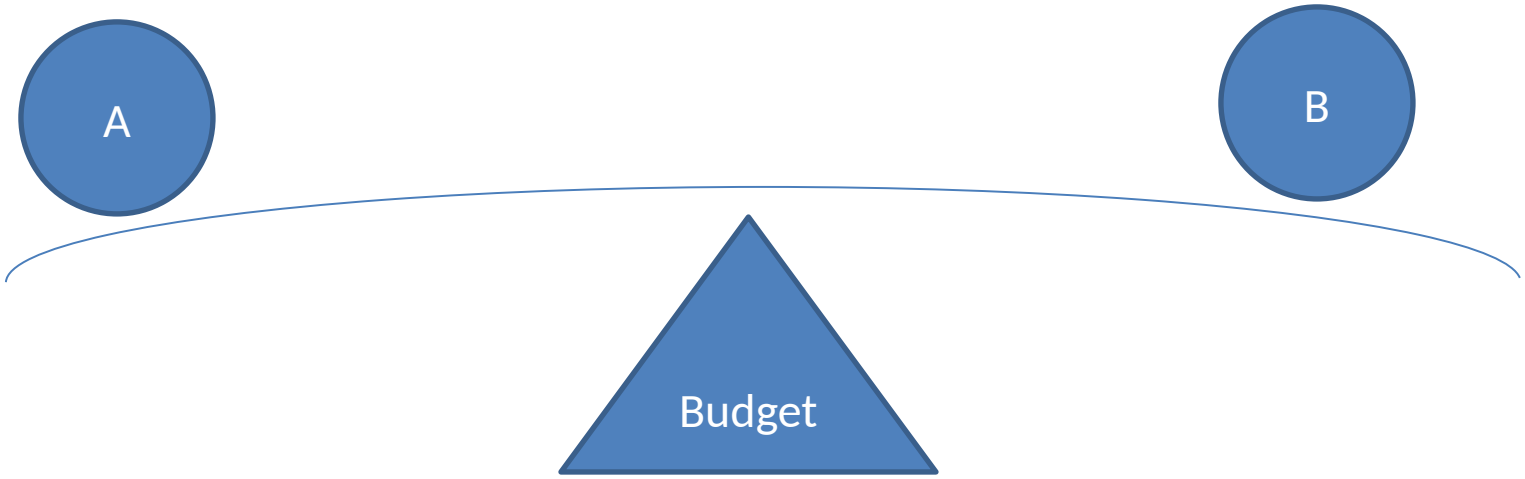
Illimité soins de santé "veut" la croissance rapide des dépenses de santé.

L'insuffisance des ressources du secteur de la santé.

Choisir entre les «désirs», nous pouvons «se permettre» donnée «budget» de notre ressource.

Concept de coût opportun

«La valeur de l'avantage manque à gagner qui pourrait être obtenu à partir d'une ressource dans sa nouvelle meilleure utilisation alternative".



L'objectif est de choisir des activités où les avantages l'emportent sur le coût d'opportunité.

Cadre théorique pour aider les professionnels de la santé, les décideurs et les gouvernements à faire des choix sur …

COMMENT … pour maximiser la santé de la population compte tenu de santé contraint la production de ressources.

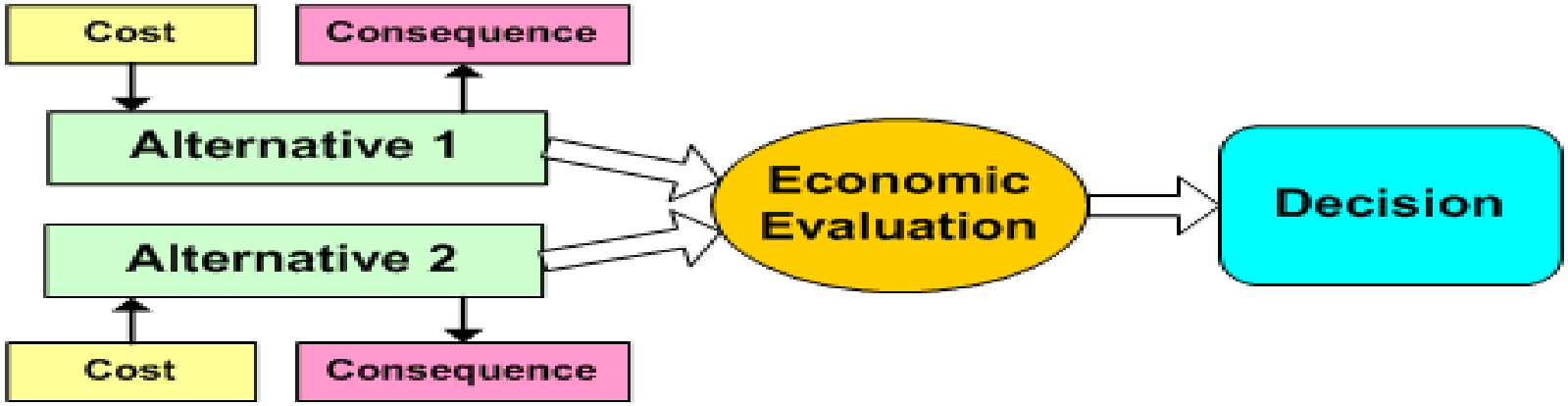
Ce que les économistes de la santé ont besoin est …

Pour comprendre la relation entre les ressources utilisées et les résultats sanitaires obtenus par d'autres options.

… Et comparez!

L'évaluation économique est ...

«L'analyse comparative des divers plans d'action en termes de leurs coûts et les conséquences afin de faciliter les décisions politiques» (Drummond et al, 1997)



L'évaluation économique n'est pas «choisir le moins cher".

Les critères d'évaluation économiques

L'évaluation économique est utilisé pour s'assurer que les ressources limitées sont allouées de manière aussi efficace que possible.
Efficacité technique: atteindre un objectif donné au moindre coût.
L'efficacité allocative: produire exactement ce que veut la société.

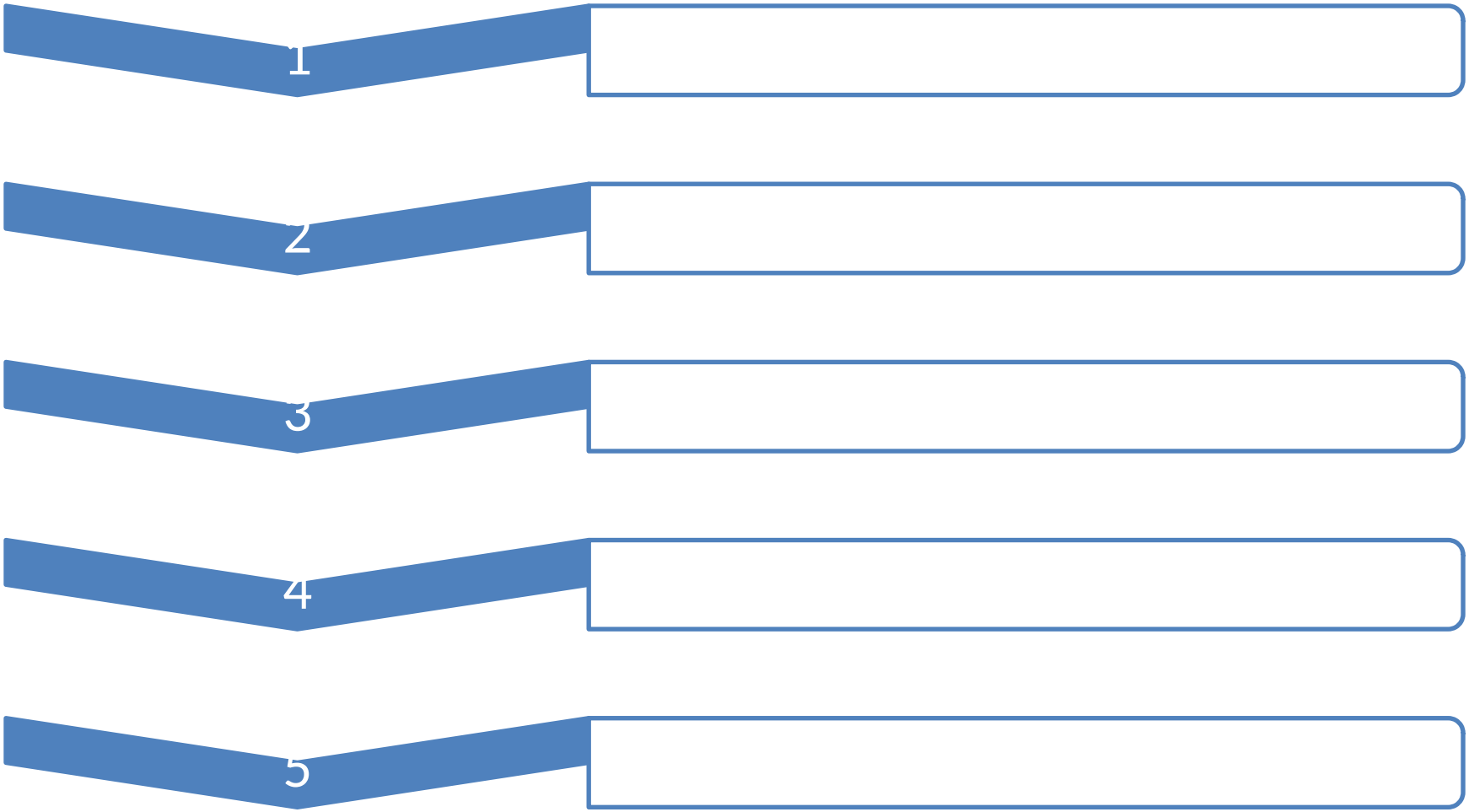
La société peut avoir d'autres objectifs lors de l'allocation des ressources: les questions d'équité ou d'éthique.

- L'équité horizontale: «traitement égal des égaux».
- L'équité verticale: 'inégalité de traitement entre partenaires inégaux.

Étapes génériques économique

Evaluation

Les étapes de l'évaluation économique



Décider de la question de l'étude

1. Identifier le problème et objectifs de l'évaluation
   Quel est le problème?
   Pourquoi ce problème est-il important?
   Quels sont les aspects du problème doivent être expliqués?

2. Choisir les options alternatives
   Décrivant les interventions avec précision.
   Définir l'intervention contrefactuelle (comparateur).

3. Définir le public
   Définir les besoins en information du public.
   Compte tenu de la façon dont le public va utiliser les résultats de l'étude.

Décider de la question de l'étude

1. Définir le point de vue de l'étude
   Patients / fournisseurs / payeurs de soins de santé / système / société.
   Choix d'un point de vue dépend de l'audience.

2. Définir le calendrier et l'horizon analytique
   Horizon analytique> Calendrier.

3. Choisir le format d'étude
   Prospective / rétrospective / Modèle.
   Dépend de données, le temps et les ressources disponibles.

Évaluation des coûts

Vue d'ensemble des coûts de processus:

- Identification des coûts
- Type de coût: direct incorporels vs vs indirecte.
- Catégorie de coût: programme, patient.
- Niveau organisationnel: national, régional, du district.
- Catégorie Entrée: récurrent vs capital.
- Les activités d'intervention: la planification, de l'administration, des médias, de la formation.
- Heure: start-up vs post-mise en œuvre.
- Financement: national gouv vs ONG bailleurs de fonds.

Évaluation des coûts

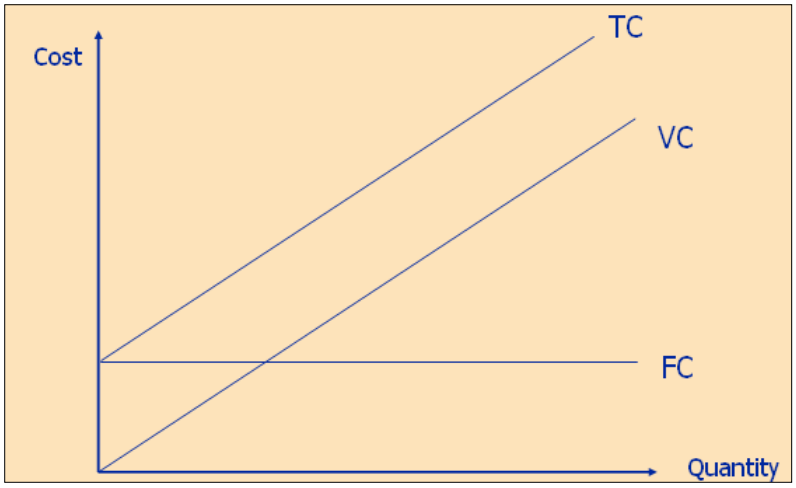
Mesures

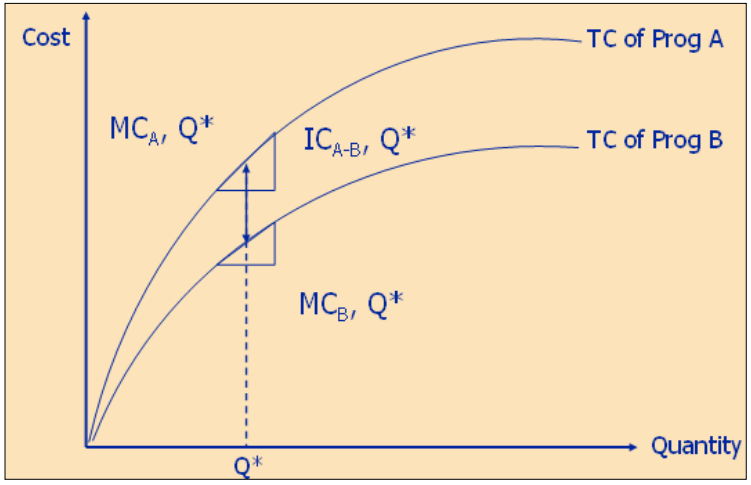
Mesures naturelles : unités physiques (par exemple heures de temps de travail).

Fixes, coûts variables et total.

Les coûts moyens par rapport marginal.

Les coûts marginaux par rapport supplémentaire.





Évaluation des coûts

Table 1: Number of cases detected & costs of screening with sequential guaiac tests

Number of tests	Total cases detected	Total costs (£)	Average cost per case detected (£)
1	65.9496	77,511	1,175
2	71.4424	107,690	1,507
3	71.9003	130,199	1,811
4	71.9385	148,116	2,059
5	71.9417	163,141	2,268
6	71.9420	176,331	2,451

(For a population of 10,000, costs include stool tests and barium-enema examinations on those found positive)

From Neuhauser and Lewicki (1975)

Évaluation des coûts

Table 2: Changes in cases detected and in costs of sequential guaiac tests

Number of tests	Additional cases detected	Additional costs (£)	Marginal cost (additional cost per additional case detected (£)
1	65.9496	77,511	1,175
2	5.4956	30,179	5,492
3	0.4580	22,509	49,150
4	0.0382	17,917	469,534
5	0.0032	15,024	4,724,695
6	0.0003	13,190	47,107,214

Évaluation des coûts

Evaluation

Les prix du marché (taux de salaire, par exemple) utilisés à moins forte conviction qu'ils ne reflètent pas le coût d'opportunité (bénévoles, par exemple).
Les monnaies locales vs devise internationale.
Ajustements pour inflation des prix.

calcul

Multipliez unité de mesure par le coût unitaire (par exemple 2 heures de temps de 5 $ l'heure = coût du travail 10 $).

Évaluation des effets sur la santé

Vue d'ensemble du processus:

identification

Qui mesure des résultats est employé dépend de l'objectif de l'évaluation.

Ceci détermine ensuite le type d'évaluation.

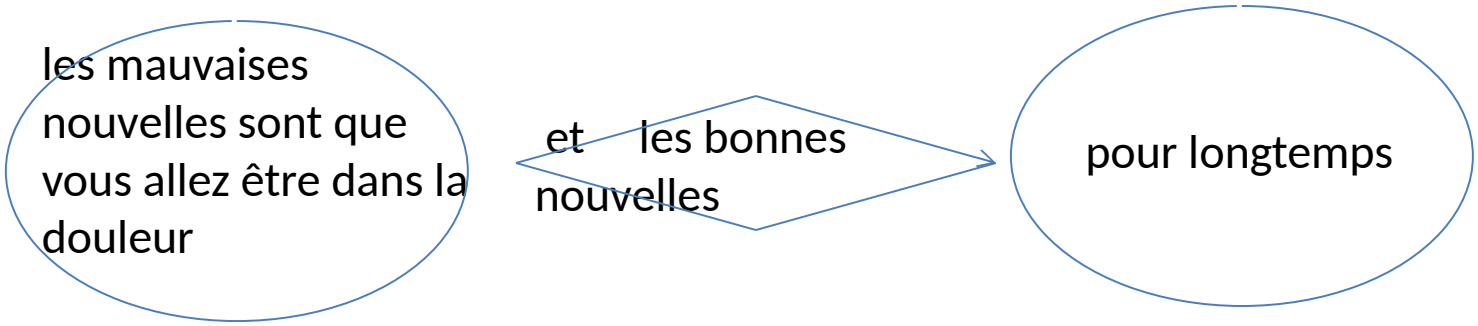
mesures

Mesurer l'efficacité n'est pas l'efficacité.

Mesure (compteur) en unités physiques naturelles.

Mesurer les résultats finaux pas intermédiaires.

Évaluation des effets sur la santé



Évaluation appropriée

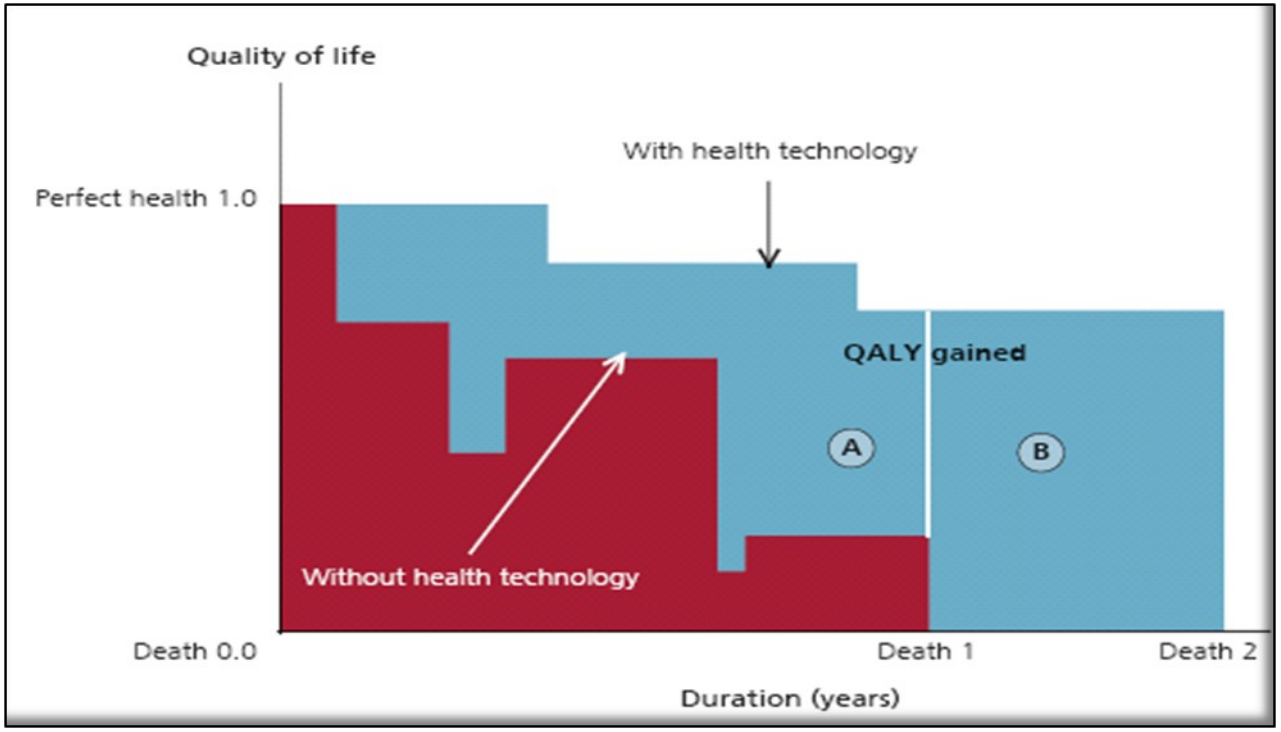
valeur est déterminée par les avantages sacrifiés par ailleurs (voir à nouveau le coût d'opportunité).

Évaluation soit en termes de:

- Utilitaire (par exemple QALITY)
- Argent (par exemple CAP)

Évaluation des effets sur la santé

- le concept de qualité:



Ajustement du calendrier

Actualisation

«Préférence temporelle» - Vous préférez avoir des avantages maintenant et supporter des coûts à l'avenir

Taux d'actualisation le taux de préférence temporelle

Afin de permettre une calendrier différentielle des coûts (et avantages) entre les programmes de tous les coûts futurs (et avantages) devraient être formulés en termes de leur valeur actuelle en utilisant le taux d'actualisation.

Ainsi, les coûts futurs accorder moins de poids que les coûts actuels.

Rente des coûts en capital

Les coûts d'investissement représentent un investissement au démarrage d'un actif qui est utilisé et amorti au fil du temps.

Annualiser l'investissement initial au cours de la durée de vie utile de l'actif.

L'analyse de sensibilité

Processus d'évaluation de la robustesse d'une évaluation économique prenant en compte les effets de l'incertitude.

Consiste à:

-- Identifier les variables (incertain).

-- Spécification de la gamme plausible sur lesquels ils devraient varier.

-- Recalculer des résultats, généralement sur la base de:

*Une analyse unidirectionnelle

*Analyse multi-voies

*L'analyse de scénarios extrêmes

*Analyse de seuil.

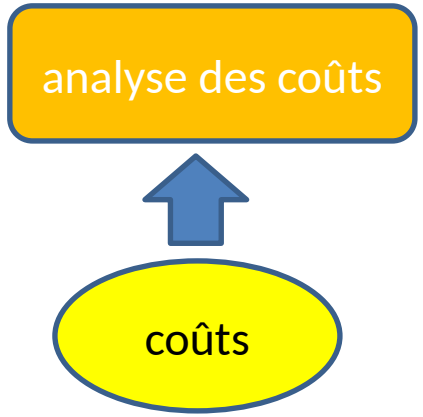
Types d’évaluation économique

Les types de base de l'évaluation économique

Analyse de minimisation des coûts (AMC)
Analyse coût-efficacité (ACE)
Analyse coût-utilité (ACU)
Analyse coûts-avantages (ACA)

Analyse de minimisation des coûts (AMC)

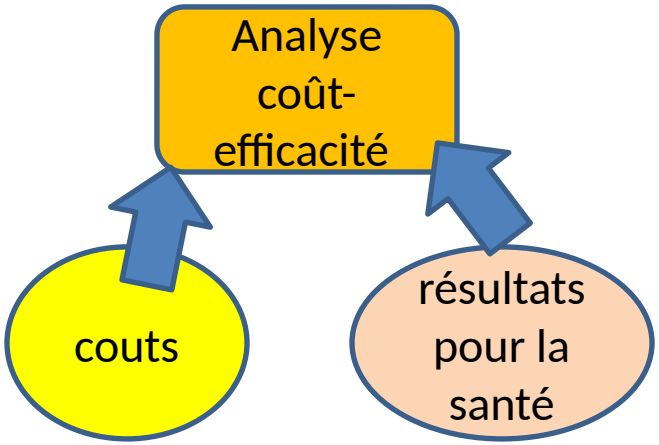
Type d'analyse spécifique dans laquelle les résultats des 2 interventions de soins de santé (ou plus) sont supposés égaux.
Par conséquent évaluation économique est basée uniquement sur les coûts comparatifs.



Résultat: solution la moins coûteuse.

Analyse coût-efficacité (ACE)

Dans l' ACE , les résultats sont mesurés en unités naturelles ou physiques (par exemple éviter les crises cardiaques, les décès évités ...).



Un seul domaine des résultats peuvent être explorés à la fois.
Résultat: le coût par unité de conséquence (par exemple, coût / année de vie gagnée)

Analyse coût-efficacité

* Règle de décision:

Deux programmes A (comparateur) et B.

Si Résultat B = Résultat A => Comparer les coûts (AMC).

Si Résultat B> Résultats A et Coût B <Coût A, B est dominant.

Si Résultat B> Résultats A et B Coût> Coût de A, nous devons prendre une décision.

*Afin de prendre une décision sur lequel l'intervention de choisir un ratio coût-efficacité (CER) doit être calculée.

Analyse coût-efficacité

Les Ratio cout-efficacité les plus couramment utilisés sont les suivants:

*Moyenne rapport coût-efficacité (MRCE)

$$MRCE = \frac{COUTB}{EFFICACITEB}$$

*Coût-efficacité différentiel (CED)

$$RED = \frac{(CoutB - CoutA)}{(EfficacitéB - EfficacitéA)}$$

La question suivante est: L'intervention est **«rentable»?**

Analyse coût-utilité

Dans l'ACU, les résultats sont mesurés en années en bonne santé, à laquelle une valeur a été fixée.

L'AUC est multidimensionnelle et comporte des considérations de qualité de vie ainsi que la quantité de vie à l'aide d'une unité commune.



Résultat: le coût par unité de conséquence (par exemple, coût / QALY).

Soins de Qualité OMS

« Délivrer à chaque patient l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en terme de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène, pour sa plus grande satisfaction en terme de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins. »

En guise de conclusion

- La place des soins primaires et de la médecine générale doit etre centrale en Algerie comme dans tous les pays modernes. C'est le lieu d'expression et de gestion préponderante des problemes de santé, de soins comme de prevention.C'est aussi l'interface de la regulation médicale et économique.
- La croissance des coûts de la medecine hospitaliere (publique et privée) et de la medecine high tech (dont les medicaments) est de plus en plus forte. Sans regulation dans ce domaine, le niveau de prise en charge des soins ambulatoires de medecine générale sera de plus en plus réduit : c'est le problème sur la définition du panier des soins remboursés sur des prelèvements obligatoires (cotisations, impôts, ,taxes..).
- Les difficulté d'acces aux soins et les niveaux actuels de remboursements : la santé comme "marché" ou la santé comme un élément de la protection sociale et de la solidarité collective ?